جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : كريمه احمد صابر احمد
المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** الاخصاص **العنوان :** -
رقم البطاقة : 29407182100546 **رقم التليفون :** 01150343611 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 11-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 18-07-1994 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: كريمه احمد صابر احمد
National ID: 29407182100546

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment

التاريخ : 05-07-2026	**الوقت :** -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : كريمه احمد صابر احمد

المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** الاخصاص **العنوان :** -

رقم البطاقة : 29407182100546 **رقم التليفون :** 01150343611 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 05-08-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 18-07-1994 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**

التوقيع:(----------) **التوقيع:(----------)**

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج كيماوي تاكسان (دوسيتاكل) **قسم العلاج :** الاورام

التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس
وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد طبيعة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفى

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالرئيسي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



كريمه
احمد صابر احمد
٢٣ ش رشدى - المطار
امبابة - الجيزه

١٩٩٤/٠٧

٢٩٤ ٠٧ ١٨ ٢١ ٠٠٥ ٤٦

LK0370520

١١١٥٠٣٤٣٦١١
١١١٥٨٦٥٦٢١



٢٠٢٥/١٠ ٢٩٤٠٧١٨٢١٠٠٥٤٦

بدون عمل

أنثى مسلمة متزوجة
حسنى محمد عبدالرحمن مرسى
البطاقة سارية حتى ٢٠٣٢/٠٩/٣٠

١

Name: كريمه احمد صابر احمد	
MR. : 2239	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient's chemotherapy was postponed for one week because of neutropenia while awaiting new breast imaging studies.

For week 16 the patient received Taxol 130 mg and Neupogen, with an absolute neutrophil count (ANC) of 1.00 ×10⁹/L; the patient was subsequently given Zoladex out-of-pocket for week 17, with CBC ordered and pharmacy follow-up scheduled for week 18.

The chemotherapy appointment was postponed again because the ANC was 0.7 ×10⁹/L; Neupogen was administered, and the patient continued metastatic breast cancer (MBC) treatment with Taxol (designated as W19, with W20 and W21 pending in the pharmacy). A CT scan is pending.

During a clinical pharmacy visit, laboratory results on 31 March showed hemoglobin 11.8 g/dL, platelets 316 ×10⁹/L, and total leukocyte count 3.8 ×10⁹/L (with neutrophils 1.3 ×10⁹/L). The patient received Taxol 100 mg with a 20 % dose reduction due to repeated episodes of neutropenia.

The patient has metastatic breast cancer involving the liver and bones. Previously, a CDK4/6 inhibitor plus FEMARA was administered for two years with disease regression and stability, but it was stopped in April 2023 per Ministry of Health protocols, after which progression of the left-breast lesion occurred. Subsequent lines included Afinitor plus aromasin (with progression and new chest opacities), followed by single-agent GEMZAR for seven cycles, then Fosolodex, Zoladex, and Zometa with three months of palliative radiation to the breast. Disease progression prompted initiation of weekly Taxol.

The patient's disease course includes premalignant MBC to liver, with imaging showing lesions in the right hepatic lobe (ER 6/8, PR 7/8) and locally advanced disease post-mastectomy (June 2020). Prior treatments comprised CDK4/6 inhibitor (4/6), hormonal therapy (AI, Zoladex) for two years, Afinitor plus aromasin, and GEMZAR for seven cycles. New left-breast skin nodules (4 mm) and hepatic lesions (9 mm) were identified; dynamic MRI of the left breast is planned, with liver MRI scheduled for week 21 and Taxol for week 22.

For week 23, a triphasic CT was ordered for radiologic assessment (MRI not approved), and the patient was scheduled for Taxol as discussed at the multidisciplinary team (MDT) meeting.

The MDT recommended a repeat biopsy from the most accessible lesion while initiating single-agent Xeloda.

Laboratory assessment confirmed a body surface area of 1.7 m²; the patient began Cycle 1 of XELODA administered twice daily (4 AM and 3 PM) for 14 days followed by a one-week rest, although the patient declined a biopsy.

تحريرا في ,

التاريخ :	21-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : dina makram

يعتمد ,

A biopsy from the hepatic focal lesion was attempted today to guide XELODA therapy, with a plan for a 7-day course after laboratory results.

Biopsy could not be performed because no hepatic focal lesion was identified by the team. The patient is now on Cycle 3 of XELODA, receiving 3 days on, 2 days off for 14 days; the next visit is scheduled for 6 September 2026. The patient has completed three cycles of XELODA.

The current plan is to assess laboratory parameters and, if acceptable, proceed with four additional cycles of XELODA and obtain a CT of the chest, abdomen, and pelvis for treatment assessment.

Patient's Name:	**KARIM ABER AHMED**
Date:	**2026-03-28**
Referred by:	Prof.Dr. **CT CAP IV**
Hospital:	**Goustave Roussey International Egypt**

MULTISCLICE POST CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS REVEALED:

A known case of managed right breast cancer.

Compared to the last CT report dated 3/7/2025, the current examination revealed

I- CHEST:

- Right MRM showed clear operative bed with no enhanced focal lesions or fluid collection.
- Bilateral apical fine reticulation denoting old granuloma.
- Left upper lung lobe subpleural reticulations likely post-radiation sequel
- Few bilateral tiny pulmonary nodules, the largest is seen on left lower lung lobe anterior segment measures about 4 mm.
- No hilar or mediastinal masses or lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collection.
- Normal plain CT appearance of the heart and great vessels.

II- ABDOMEN AND PELVIS:

Compared to the last CT report dated 3/7/2025, the current examination revealed

- Average sized liver showing homogenous parenchymal attenuation. Newly developed right hepatic lobe segment V/VI hypodense focal lesion measures about 9mm for further triphasic CT
- No dilated biliary radicles.
- The gall bladder is well distended, average wall thickness with no stones.
- Both kidneys are normal site, average sized and showing smooth regular cortical outline and preserved parenchymal thickness and function. No stones or back pressure changes.
- Normal C.T appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, aorta and IVC.

Patient's Name:	**KARIM ABER AHMED**
Date:	**2026-03-28**
Referred by:	Prof.Dr. **CT CAP IV**
Hospital:	**Goustave Roussey International Egypt**

- The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulae or stones.
- Normal appearance of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- No abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.
- **The examined skeleton still seen** D11, L5 osseous hemangiomata

Opinion:

- **Newely developed hepatic FL for dynamic MRI study.**
- **Stationary rest of study**

Dr.Nourhan Ramzy

Dr.Nourhan Ramzy

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

[[DOCTYPE:CT_SCAN]]
CT Scan

Medical No. : **10488**
Patient's Name: Karima Ahmed Saber Ahmed
Date: 2026-10-06
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: **Goustave Roussey International Egypt**

MULTISLICE POST CONTRAST CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS:

TECHNIQUE:

Multislice axial CT images of the chest, abdomen and pelvis obtained from the lower neck to the symphysis pubis with multiplanar reconstruction. IV contrast was used (No previous Dicom images or reports for comparison).

FINDINGS:

(I) Chest:

- **Noted right upper love apical pulmonary nodule measuring 7 mm.**
- **Noted nodular opacities with tree in bud appearance surrounded by ground glassing in the right lower lung zone posteriorly and lower left lung zone likely are of inflammatory bronchiolitis and bronchopneumonitis more evident in right side**
- **No evidence of pulmonary masses or cavitation.**
- **No sizeable hilar or mediastinal masses or lymph node enlargement.**
- **No evidence of pleural or pericardial effusion.**
- **Normal appearance of the heart and great vessels.**
- **Noted multi-level small dorsal vertebral lytic lesions with T11 vertebral sclerosis with lytic lesions.**

(II) Abdomen and pelvis:

- **The liver is average in size showing diffuse hypo dense yet homogenous CT density, with noted right hepatic lobe subcapsular segment VIII enhancing focal lesion measuring (1.9x1.5cm) likely is of metastatic process**
- **Patent and homogenously enhancing portal vein.**
- **No intra or extra hepatic biliary radicles dilatation.**
- **Normal CT appearance of the pancreas, both kidneys, aorta and IVC.**
- **Normal CT appearance of the spleen .**
- **Regular filling of the urinary bladder showing no stones, masses .**
- **Unremarkable other pelvic organs.**
- **No retro-crural, para-aortic or pelvic lymphadenopathy.**
- **No ascites.**
- **Noted lumbar vertebral lytic lesions in L1 & L2 with L5 vertebral sclerosis with lytic lesions.**

OPINION:-

- **Right upper lobe pulmonary nodule measuring 7 mm.**
- **Bilateral lower lung zone small segmental areas of inflammatory process bronchiolitis and bronchopneumonitis.**
- **Hepatic enhancing focal lesion as detailed likely is of metastatic process.**

[[DOCTYPE:CT_SCAN]]
CT Scan

Medical No. : **10488**
Patient's Name: Karima Ahmed Saber Ahmed
Date: 2026-10-06
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: **Goustave Roussey International Egypt**

- **Vertebral body multi-level lytic lesions and sclerotic L5 and L11 bodies.**

Best regards,
Dr. Ayman Shawky, FEBR